Resumo de Otorrino · HP

texto em roxo = caiu na T10 (pelo relato) · ✎ T10 = cobrado com outras palavras

Antes de tudo

Como a prova de otorrino funciona

A prova de HP de otorrino é da **professora**, otorrinolaringologista. Não temos a prova em papel: temos o **relato da turma 10**, com o tema de cada questão, o gabarito das 20 objetivas e as respostas das **3 discursivas**. O que está grifado em roxo neste resumo é o que, pelo relato, caiu na T10. As notas ✎ *T10* marcam o que a prova cobrou com palavras que não estão exatamente nos slides.

Três padrões aparecem no relato. Primeiro, **muita questão de "qual destes NÃO é"**: "salivação excessiva não é sintoma de epistaxe", "exterior não é seio paranasal", "calendário vacinal não causa otite crônica", "coloração perolácea não é da OMA". A resposta é o item que destoa, e quase sempre é uma coisa absurda ou o contrário do slide. Segundo, a prova é **de conduta prática**: quando lavar o ouvido, o que fazer com uma larva viva, de onde vem o sangramento. Terceiro, as discursivas pedem **diagnóstico + mecanismo + conduta** de três quadros clássicos: otite média serosa por adenoide, epistaxe posterior e abscesso periamigdaliano.

Onde cai mais: otites (aula 3) é a aula mais cobrada, seguida de urgências (epistaxe, corpo estranho, miíase) e de rinossinusite/amigdalite. Rinite entra com o exame físico do alérgico. Laringe não apareceu no relato da T10, mas é curta: leia uma vez.

Aula 1 · Semiologia

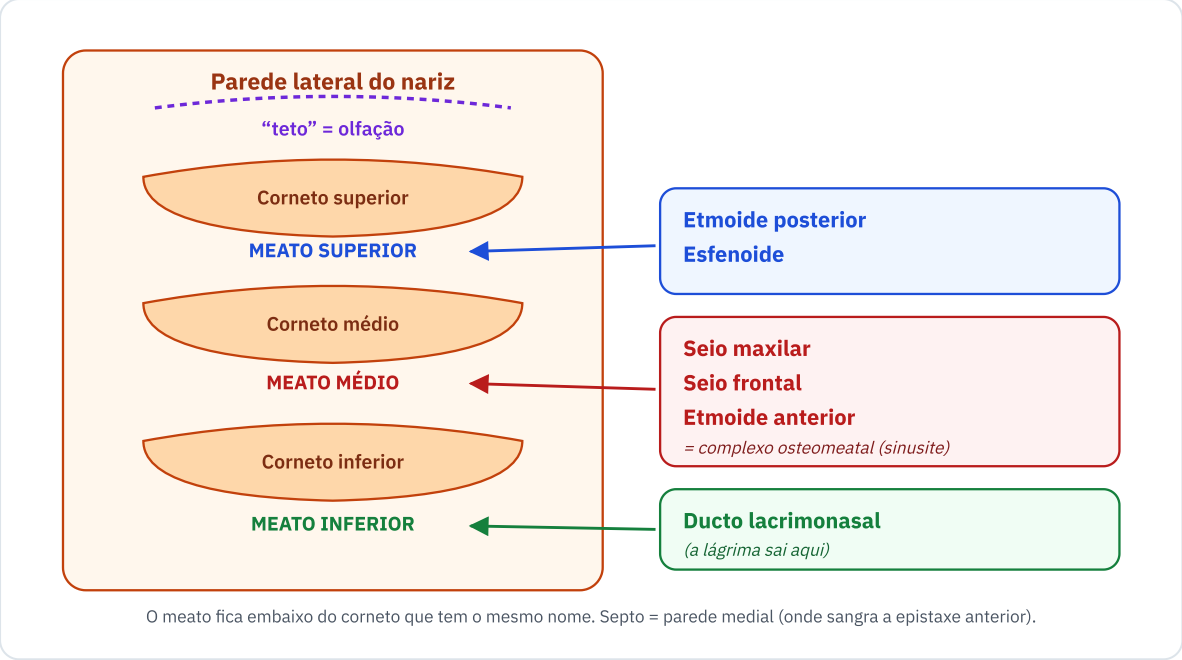
Rinoscopia, otoscopia, oroscopia e pescoço

Rinoscopia

A avaliação do nariz começa pela anamnese. Os sintomas a perguntar são obstrução nasal, coriza/rinorreia (anterior ou posterior), dor, espirros, prurido, alteração do olfato, **cacosmia** (percepção de cheiro ruim), cefaleia, **epistaxe** e voz nasalada. O exame físico tem quatro tempos: **inspeção** (pele e deformidades), **palpação** ("ossos", partes moles e vestíbulo), **rinoscopia anterior** e **rinoscopia posterior**.

Para entender o que se vê, guarde a anatomia da parede lateral. Cada lado do nariz tem três cornetos (superior, médio e inferior), e embaixo de cada um fica o meato de mesmo nome. Os seios paranasais drenam para esses meatos: o meato médio recebe o óstio do seio maxilar, do frontal e do etmoidal anterior; o meato superior recebe o etmoide posterior e o esfenoide; e **a lágrima sai no meato inferior** (ducto lacrimonasal). A olfação acontece no "teto" do nariz. Os seios paranasais são quatro pares — maxilar, frontal, etmoidal e esfenoidal.

> ✎ *T10: uma questão listava os seios e pedia o que NÃO é seio paranasal — a resposta era "exterior". Outra tinha como resposta o **seio frontal**.*



Quem drena onde. O meato médio (maxilar, frontal, etmoide anterior) é o centro da rinossinusite.

Técnica. Primeiro avalia-se o vestíbulo (desvio septal caudal ou outras lesões). Na rinoscopia anterior, médico e paciente ficam frente a frente; o médico destro segura o espéculo com a mão esquerda, introduz **fechado** e retira **semiaberto**, para não arrancar um pelo. Avalia-se o septo (desvio, perfuração, ulceração, hematoma, abscesso, cor da mucosa), o meato comum, o assoalho e a parede lateral (cornetos inferior e médio). Na rinoscopia posterior entram os testes de função nasal: **espátula gelada** (o ar expirado embaça o metal) e **manobra de Cottle** (tracionar a bochecha lateralmente abre a válvula nasal; se melhora, o problema é de válvula).

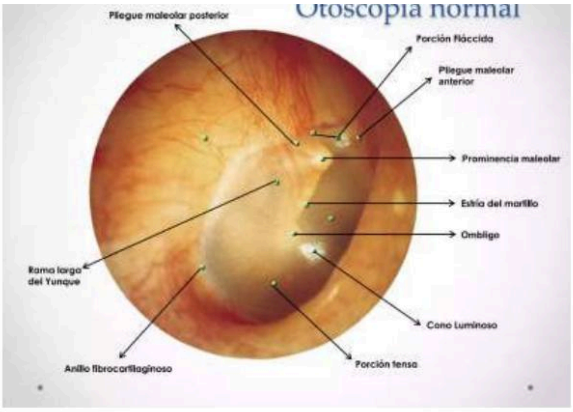
O que a rinoscopia mostra: mucosa pálida = rinite; crostas em excesso = rinite atrófica/ozenosa; massas brilhantes = polipose nasal.

Inspeção da pele. Celulite (hiperemia, edema e pele tensa; S. pyogenes e S. aureus); furúnculo (ponto pustuloso, infecção do folículo piloso por S. aureus). Carcinomas ligados ao sol: o **CBC** é o tumor maligno mais frequente da pele (75%), em locais com pelo, 1/3 no nariz; o nodular tem bordas peroladas, cor rósea, telangiectasias e centro que pode ulcerar. O **CEC** é um nódulo que evolui para úlcera, mais rápido que o CBC. Granulomatoses nasais (sífilis, leishmaniose, hanseníase, TB, Wegener, lúpus...) deformam o nariz (nariz de tapir, lupus pernio). Outras deformidades: nariz em sela, giba osteocartilaginosa, traumas, cisto dermoide.

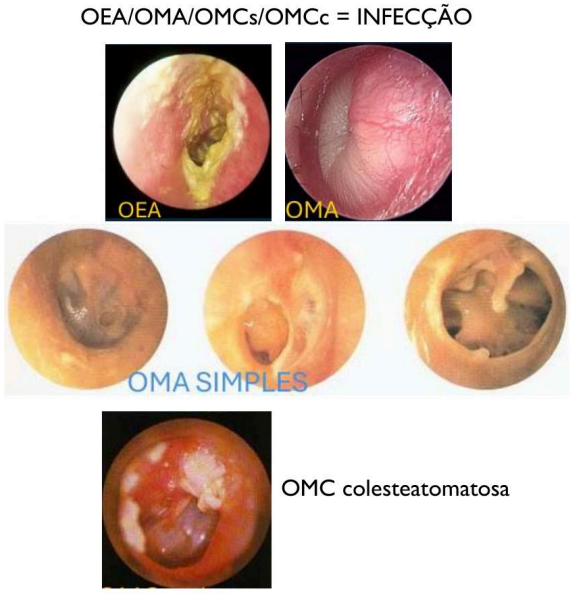
Otoscopia

O objetivo é ver a **integridade da membrana timpânica (MT)** e as alterações da orelha externa e média. Na anamnese: dor de ouvido (otalgia), secreção (otorreia), sangramento (otorragia), perda auditiva, sensação de plenitude/pressão e zumbido (tinnitus).

Na inspeção, avalia-se tamanho e forma da orelha, cor da pele do pavilhão e do MAE. No MAE procura-se edema, secreção, **corpo estranho**, cerume e alterações na estrutura. O **otocone deve ser o maior que vede o conduto**. Depois vêm a palpação, a "ausculta" da audição com diapasão (**Weber e Rinne**) e os testes de função vestibular.



Otoscopia normal: MT translúcida, cabo do martelo e triângulo luminoso.



Os quadros da aula. OEA, OMA, OMC simples e colesteatomatosa são infecção; a OMS/OME é estéril.

As alterações da orelha externa vistas à inspeção são congênitas (agenesia, microtia, aplasia do MAE, orelhas proeminentes). No otoscópio, a aula separa **OEA, OMA, OMC simples e OMC colesteatomatosa = infecção**; a **otite média serosa/efusiva é estéril**.

Oroscopia e pescoço

Paciente sentado, boa luz, **dentadura removida**. Avaliam-se dentes, lábios, gengiva, mucosa jugal, abertura/oclusão da boca, palato, aspecto e mobilidade da língua. O **assoalho da boca deve ser palpado**: cálculos nas glândulas submandibular e sublingual causam halitose, dor e gosto ruim; endurecimento sugere tumor.

Para ver a amígdala, a **língua fica dentro da boca** e o abaixador entra só até **2/3 da língua**, para não provocar reflexo de vômito. Avalia-se volume, cor e criptas (os “buracos”); o **cáseo** é o acúmulo de restos nas criptas. Amigdalite = vermelhidão + pontos brancos (placas de pus) + úvula edemaciada. A amígdala pode ser palpada (tumor).

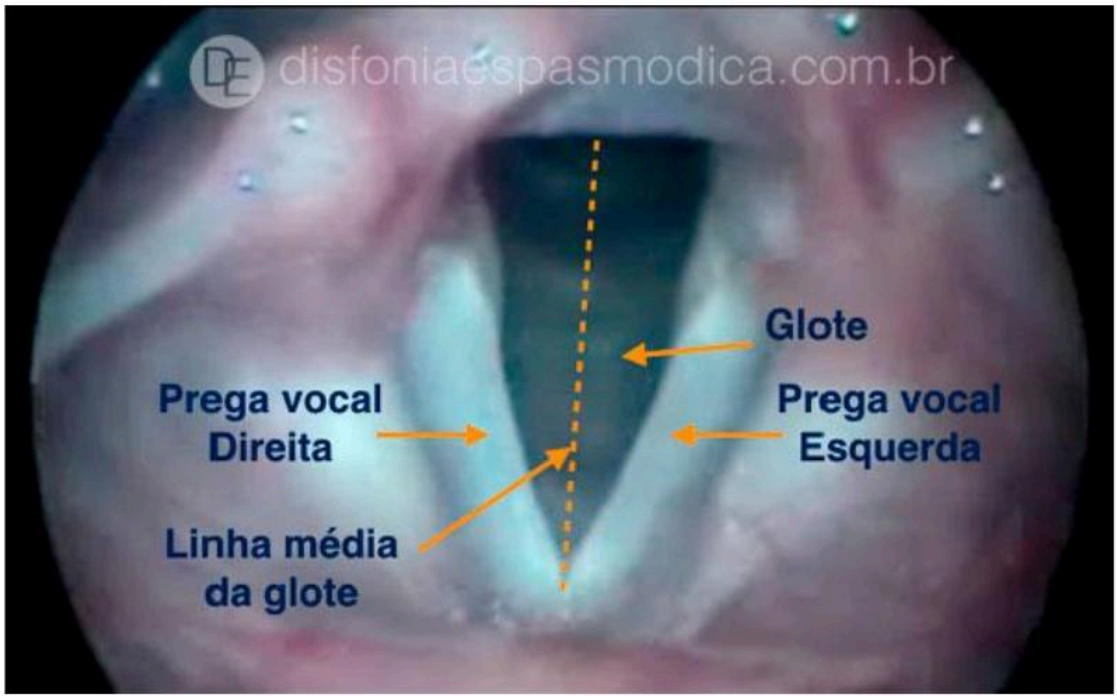
Linfonodos. Normalmente não são visíveis. Avalia-se se são duros ou moles, móveis ou fixos, local, tamanho, dor e consistência. **Suspeita de câncer: duro, fixo, indolor, crescimento lento e progressivo. Inflamatório: mole, doloroso, móvel, cresce rápido.** O esternocleidomastóideo divide as cadeias anterior e posterior. O examinador fica de frente, com a cabeça do paciente fletida e apoiada na sua mão, e palpa com a polpa dos dedos: pré-auricular, retroauricular, submentoniana, submandibular, cervical anterior, cervical posterior, occipital e supraclavicular.

Aula 1 · Laringe

Noções básicas de laringe

A laringe tem três funções: **respiração, produção da voz (fonação) e proteção das vias aéreas**. Fica na região cervical anterior, entre a faringe e a traqueia, nos níveis **C3 a C6**. Suas cartilagens são **tireoide, cricoide, epiglote e aritenoides**. As **pregas vocais verdadeiras fazem a fonação**; as **falsas, a proteção**. A

inervação vem do **nervo laríngeo superior** e do **laríngeo recorrente** (que pode ser lesado em cirurgias cervicais).



Videolaringoscopia: pregas vocais e glote.

Laringite: inflamação, rouquidão, geralmente viral. **Nódulos vocais**: uso excessivo da voz → rouquidão crônica. **Edema de glote**: emergência médica — estridor inspiratório, dispneia, risco de obstrução da via aérea, potencialmente fatal. **Câncer de laringe**: tabagismo e álcool; **rouquidão persistente por mais de 3 semanas** deve ser investigada. A mensagem final da aula: rouquidão nem sempre é banal.

Aula 2 · Rinite

Rinite: diagnóstico e tratamento

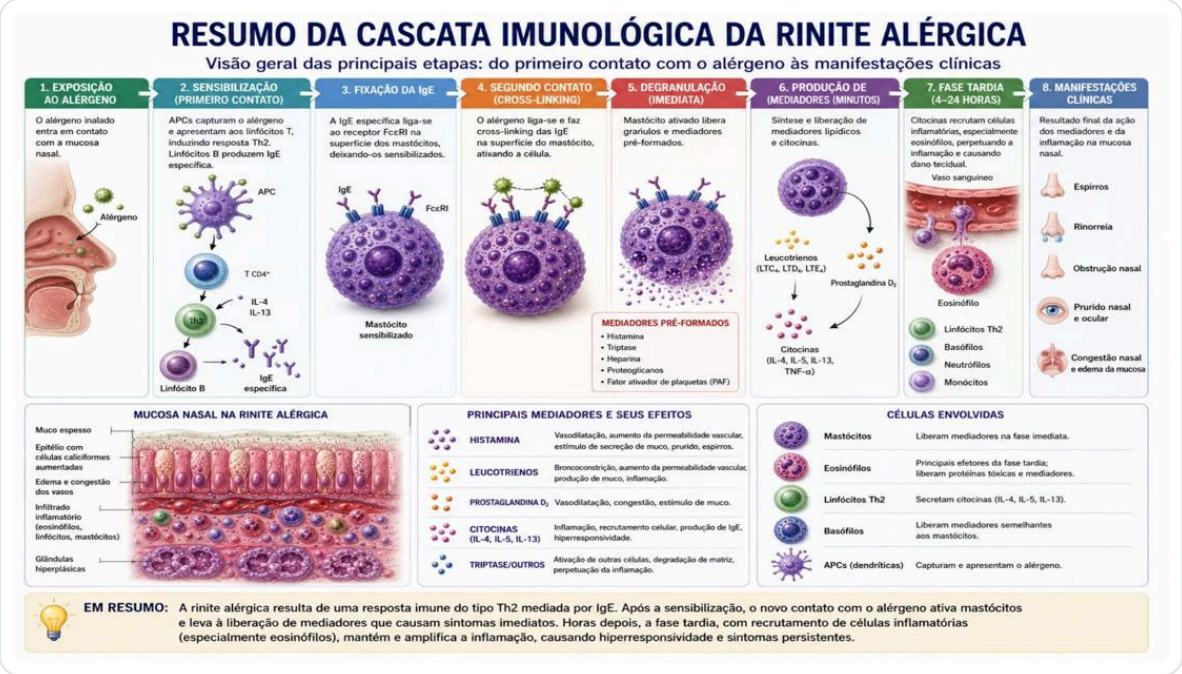
O nariz tem três funções: defesa imunológica, **aquecimento, umidificação e filtragem do ar**, e olfato. Rinite é a **inflamação da mucosa nasal** (nasossinusal), com obstrução, rinorreia, espirros e prurido — que não precisam estar todos presentes. Para chamar de rinite, os sintomas devem durar **mais de 2 dias consecutivos e mais de 1 hora na maior parte dos dias**. Divide-se em **infecciosa** (viral, bacteriana, fúngica) e **não infecciosa**, que pode ser **alérgica** ou **não alérgica** (eosinofílica não alérgica/RENA, irritativa, hormonal, gestacional, induzida por fármacos, vasomotora/idiopática).

Epidemiologia: a rinite alérgica afeta 20 a 40% da população mundial. No Brasil, o ISAAC (1996) achou 26,6% em crianças e 25,7% em adolescentes; o AILA (2008) achou 8,8% (17 milhões). A prevalência sobe com poluição, ambientes pouco ventilados, alimentação, tabagismo e sedentarismo. O impacto é real: sono ruim, queda do rendimento escolar e profissional, custos altos e dificuldade de adesão.

Rinite alérgica: o mecanismo

É uma hipersensibilidade **tipo I (Gell e Coombs), mediada por IgE**. No primeiro contato (sensibilização, sem sintomas), a célula apresentadora de antígeno ativa o **linfócito Th2**, que libera **IL-4 e IL-13**; o linfócito B vira plasmócito e produz **IgE**, que se fixa nos mastócitos. No segundo contato, o antígeno liga duas IgE no mastócito (cross-linking) e ele degranula: a **histamina** causa vasodilatação, espirro e prurido — é a

reação imediata. A IL-8 e outras quimiocinas atraem **eosinófilos**, que mantêm a inflamação por 4–24 h: é a **reação tardia**, responsável pela obstrução persistente.



Cascata da rinite alérgica (aula “Reação alérgica”): sensibilização → IgE no mastócito → degranulação (fase imediata) → eosinófilos (fase tardia).

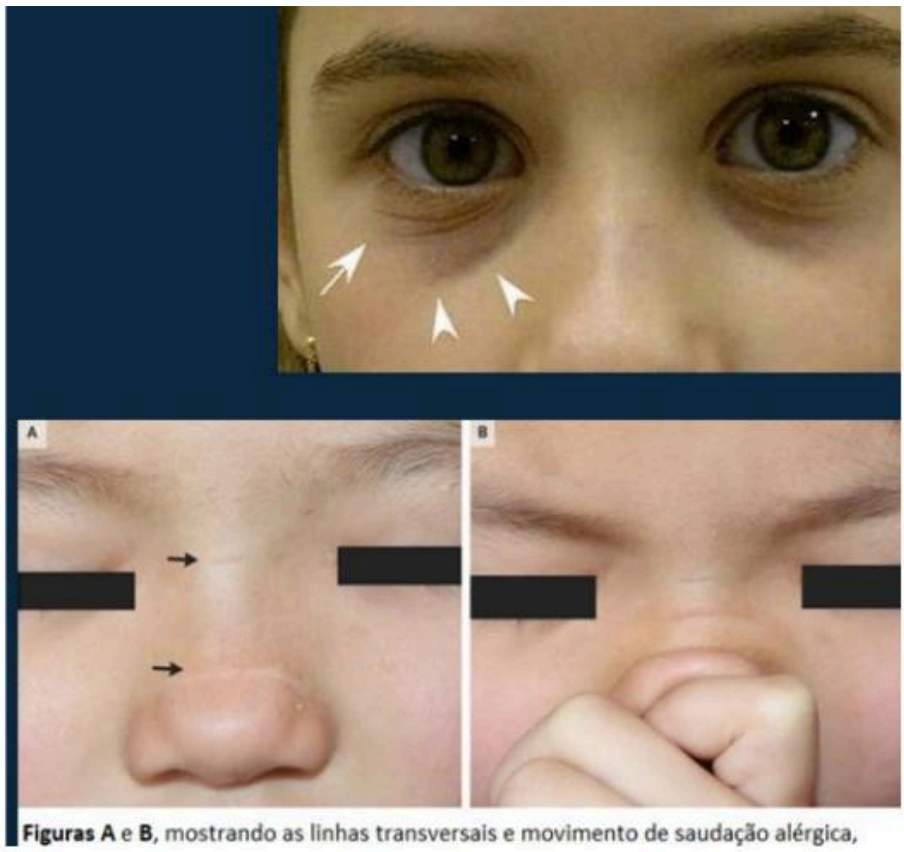
Os alérgenos são **ácaros (o mais comum)**, pólen, animais domésticos, fungos e baratas; alérgeno alimentar é raro. O início é entre **4 e 20 anos**, com outras alergias associadas.

Classificação (ARIA)

Intermitente: sintomas < 4 dias por semana *ou* ≤ 4 semanas. **Persistente**: > 4 dias por semana *e* ≥ 4 semanas. **Leve**: sono e atividades normais, sintomas não incomodam. **Moderada/grave**: um ou mais de — sono comprometido, atividades comprometidas, sintomas incomodam.

Quadro clínico e exame

Na anamnese: início dos 4 aos 20 anos, alérgeno desencadeante, **obstrução em báscula (alternante)**, **espirros em salvas**, prurido nasal e/ou ocular, coriza hialina e história pessoal ou familiar de alergia. No exame: **mucosa pálida**, rinorreia, hipertrofia de cornetos inferiores, e os sinais faciais do alérgico — olheira, dupla linha de Dennie-Morgan e prega nasal horizontal (a prega vem da “saudação do alérgico”, esfregar o nariz para cima).



Figuras A e B, mostrando as linhas transversais e movimento de saudação alérgica,

Dupla linha de Dennie-Morgan, olheira e a saudação do alérgico que cria a prega nasal horizontal.

Diagnóstico

É clínico. Não se pede exame de imagem de rotina. Os testes alérgicos servem para guiar prevenção e imunoterapia: o **cutâneo** (prick test, intradérmico) é mais barato e exige suspender o anti-histamínico por 5–15 dias; o **sérico** (IgE específica, RAST) é mais específico e fica para quando o cutâneo não pode ser feito.

Tratamento

1) **Controle ambiental**: reduzir poeira, evitar animais. 2) **Medicamentos**: irrigação com soro fisiológico (baixo volume = manutenção; alto volume, 60–100 mL, não de rotina, pela tuba auditiva). O **corticoide nasal é a primeira escolha**: age em obstrução, rinorreia e prurido. **Fluticasona não é segura na gestação — prefira budesonida.** Doses: beclometasona 100–400 mcg/dia (> 6 anos), budesonida 64–400 (> 6 anos), fluticasona 55–200 (> 2–4 anos), mometasona 100–200 (> 2 anos), triancinolona 110–440 (> 4 anos).

O **anti-histamínico H1** age rápido mas quase não melhora a obstrução. Os de **1ª geração** (clorfeniramina, hidroxizina, difenidramina) atravessam a barreira hematoencefálica (sono) e bloqueiam receptores muscarínicos (boca seca, taquicardia, retenção urinária). Os de **2ª geração** (loratadina, cetirizina, fexofenadina, bilastina, rupatadina) sedam pouco. **Antileucotrienos**: rinite + asma, ou quem não adere ao corticoide. **Cromoglicato**: estabiliza o mastócito, é profilático, demora 2–4 semanas e não age na obstrução. 3) **Imunoterapia (“vacina”)**: a **única terapia que altera a história natural**, para falha do tratamento.

Descongestionante. Oral: não usar em menores de 4 anos (vem associado a anti-H1 de 2ª geração com pseudoefedrina). Nasal: **efeito rebote = rinite medicamentosa se usado por mais de 7 dias**; evitar em lactentes e idosos; cuidado com glaucoma de ângulo fechado, doença cardiovascular, hipertireoidismo e hiperplasia prostática.

Rinites não alérgicas

Idiopática (vasomotora): etiologia desconhecida, hiper-reatividade a fumaça, temperatura e odores, adultos de 40–60 anos, tratada com corticoide tópico. **Medicamentosa**: abuso do descongestionante tópico. O rebote tem dois mecanismos — isquemia da mucosa (estímulo α2 → vasoconstrição intensa) e taquifilaxia (o receptor perde sensibilidade, o paciente aumenta a dose e responde menos às catecolaminas endógenas, α1). **Induzida por drogas**: obstrução nasal por anti-hipertensivos (IECA, betabloqueador, metildopa), AINEs e sildenafila; o tratamento é suspender a droga.

> ✎ *T10: um item dizia que a rinite vasomotora tem "etiologia conhecida" — era o falso.*

Aula 3 · A aula mais cobrada

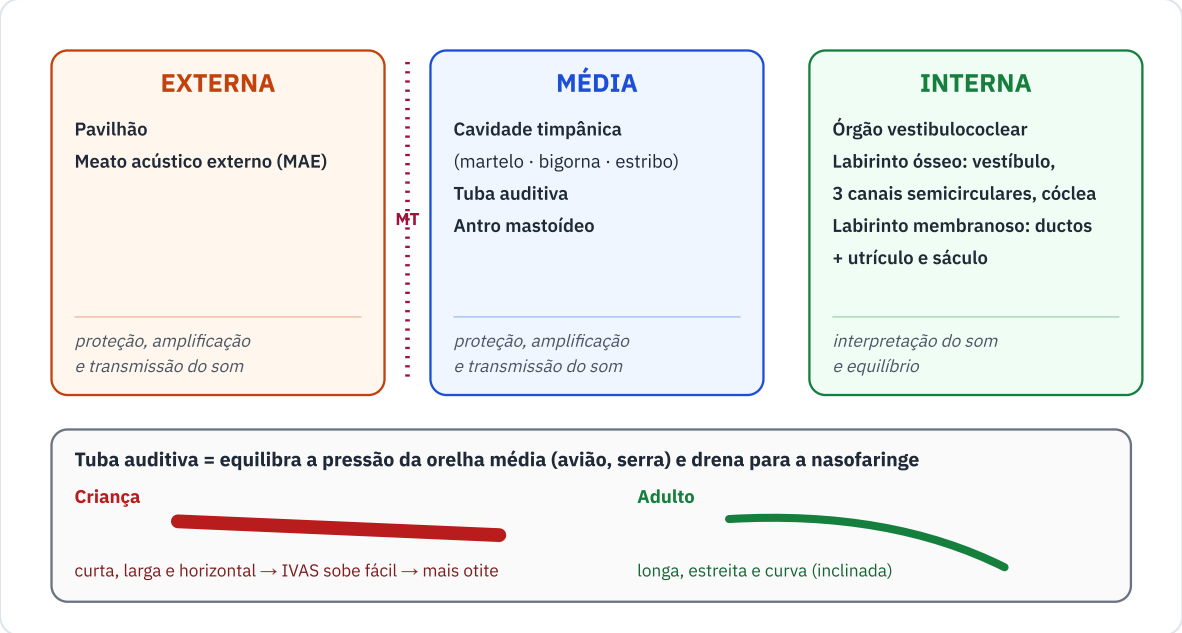
Otites e exames auditivos

Anatomia que explica as otites

A orelha tem três partes. A **externa** (pavilhão + MAE) e a **média** (cavidade timpânica com os ossículos, tuba auditiva e antro mastoídeo) fazem **proteção, amplificação e transmissão do som**. A **interna** (órgão vestibulococlear: labirinto ósseo com vestíbulo, 3 canais semicirculares e cóclea; labirinto membranoso com ducto coclear, ductos semicirculares, utrículo e sáculo) faz a **interpretação do som e o equilíbrio**. A MT separa externa de média.

Por isso o raciocínio da prova funciona assim: um corpo estranho no conduto externo não causa distúrbio de equilíbrio, porque o equilíbrio é da orelha interna. E a tuba auditiva equilibra a pressão da orelha média com o ambiente; na criança ela é curta, larga e horizontal, por isso a IVAS sobe fácil e a criança tem mais otite.

> ✎ *T10: uma questão de "I, II e III corretas" era sobre anatomia e função do meato acústico externo (a resposta era as três certas).*



As três partes da orelha e a tuba: horizontal na criança, inclinada no adulto.

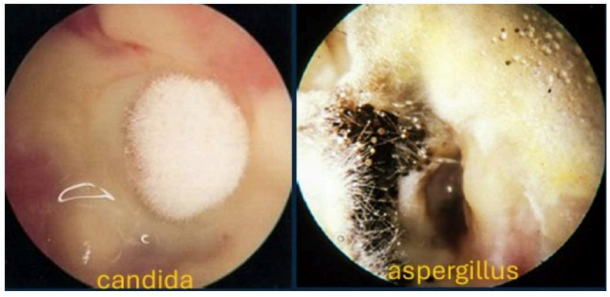
Otites externas

São inflamações/infecções do conduto e/ou do pavilhão. A primeira regra de todas: **não molhar o ouvido**.

Otite externa bacteriana aguda (OEA). Pode ser **difusa** (epitélio do MAE e/ou pavilhão) ou **localizada** (furúnculo). Acontece em quem faz **atividade aquática** ou trauma local (cotonete, lavagem excessiva, ferimento). O agente mais frequente é a ***Pseudomonas aeruginosa*** (outros: S. aureus, Peptostreptococcus, Bacteroides, Proteus). O quadro: otalgia, **dor à palpação do trágus**, prurido, **hipoacusia**, otorreia purulenta ou hiperemia do conduto, **MT íntegra**, febre. Tratamento: limpeza do MAE (aspiração ou mecânica) + analgesia; **antibiótico TÓPICO** (neomicina, ciprofloxacino, polimixina B, cloranfenicol), com ou sem corticoide (hidrocortisona, fludrocortisona, fluocinolona) e/ou anestésico (lidocaína). Se a gota não entra no conduto edemaciado, coloca-se um pedaço de algodão com antibiótico (mecha). Antibiótico sistêmico só se as gotas falharem ou em quadros graves. Furúnculo que não melhora com gota → drenagem. Em ouvido perfurado, evitar gotas com aminoglicosídeo (ototóxicas).

> **PEGADINHA T10**
> O relato traz “otite externa: otalgia, *não causa hipoacusia*” como resposta de uma questão. No slide, **hipoacusia está na lista de sintomas da OEA** (o conduto fecha de edema e secreção). Se aparecer “a otite externa não causa hipoacusia”, essa frase é a **falsa**.


OEA: conduto hiperemiado, edemaciado, com secreção.



OE fúngica: Candida (massa branca) e Aspergillus (hifas escuras).

Otite externa fúngica. Clima quente e úmido, uso frequente de antibiótico, diabéticos, imunossuprimidos; fatores: calor, umidade, mudança de pH e da flora. O mais frequente é **Aspergillus** (depois Candida). O quadro é igual ao da bacteriana, com muito prurido; a otoscopia pode mostrar hifas (nem sempre). Limpeza + analgesia (não lavar: fungo gosta de umidade) e **antifúngico tópico** — clotrimazol, miconazol, cetoconazol, ciclopiroxolamina, nistatina. Com **MT perfurada: clotrimazol, miconazol ou nistatina**. Antibiótico só se houver infecção bacteriana secundária.

Otite externa necrotizante ("maligna"). Idoso e imunossuprimido — diabético descompensado, HIV, QT/RT. Agente: **P. aeruginosa**. Igual às anteriores + **otorragia**, sintomas mais graves e **tecido de granulação** no conduto. Invade orelha média e interna, osso temporal, base de crânio, parótida e pares cranianos (**paralisia facial**). Conduta: **internação**, imagem (TC, RM, cintilografia), analgesia, **antibiótico sistêmico + desbridamento**.

Pericondrite. Após trauma (piercing) ou infecção (celulite, erisipela). Agente mais comum P. aeruginosa; na celulite/erisipela, S. aureus e S. pyogenes. Febre, otalgia, edema e hiperemia do pavilhão (± MAE). Analgesia, limpeza, antibiótico VO (penicilina + cefalexina/ciprofloxacino/clindamicina); abscesso → drenagem. **Dermatite** (contato, atópica, seborreica): prurido, descamação, hiperemia, edema → corticoide tópico + anti-histamínico.

Otite herpética (herpes-zóster). Reativação do varicela-zóster, sobretudo na **6ª década**. Dor e queimação unilateral com vesículas/crostas. **Síndrome de Ramsay Hunt = paralisia facial periférica + vesículas (principalmente na concha)**. Tratamento: cuidados locais, **aciclovir em dose dobrada** (400–800 mg de 4/4 h por 7–10 dias) + **prednisona 1 mg/kg** na fase aguda; com paralisia facial, **proteger o olho** (pomada, para evitar ceratite).



OE necrotizante: tecido de granulação no conduto (seta).



Ramsay Hunt: paralisia facial + vesículas na orelha.

Otites médias

Processo inflamatório-infeccioso da orelha média, principalmente em crianças, quase sempre precedido de IVAS. Fatores que predispõem: idade < 7 anos, imunidade imatura, tuba horizontalizada, desnutrição, alergia, IVAS, malformação de palato; creche, tabagismo passivo, poluição. A IVAS leva à otite serosa, que

pode infectar e virar OMA, e a OMA pode deixar efusão (serosa). Pela duração: **aguda < 3 meses**, **crônica > 3 meses**, **recorrente = 3 episódios em 6 meses ou 4 em 12 meses**.

A aula divide as otites médias em três: aguda (bacteriana), serosa e crônica.

Otite média aguda (OMA). Pode ser viral (VSR, adenovírus, influenza) ou bacteriana — **65–70%**, com **S. pneumoniae e H. influenzae** como os mais comuns (a vacina antipneumocócica reduz) e **Moraxella catarrhalis**. Quadro: otalgia (50–75%), febre (50%); na criança, irritabilidade, choro, vômito; vem **3–4 dias depois de uma IVAS**. A otoscopia mostra **ABAULAMENTO da MT (especificidade 97%)**, que fica hiperemiada e **opaca** — a coloração perolácea (brilhante, translúcida) NÃO é da OMA. A mensagem da professora: **"meu filho passou a mão no ouvido" não é otite; otite é abaulamento + dor**, com IVAS prévia.



OMA: membrana abaulada, hiperemiada e opaca.

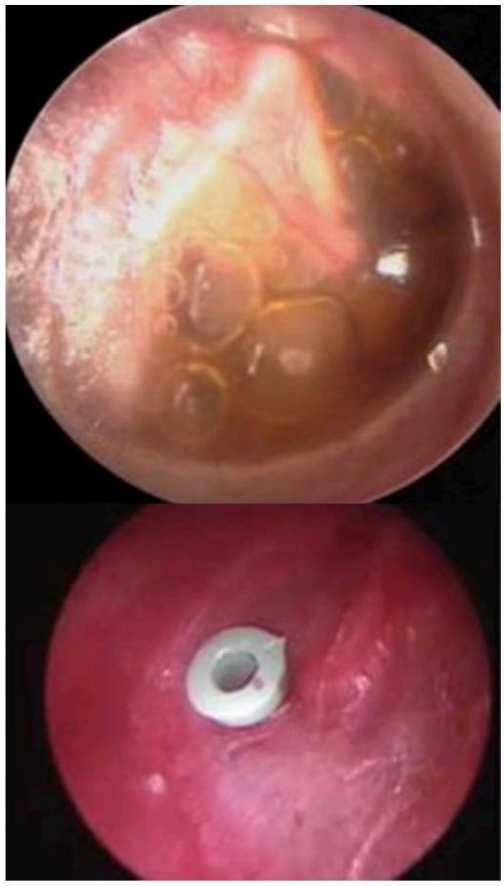
Tratar ou observar. OMA supurada (com otorreia) ou grave = antibiótico sempre. Unilateral sem otorreia pode ser observada em qualquer idade; bilateral sem otorreia só se observa na criança maior de 2 anos. E **só se observa se der para garantir reavaliação em 48–72 h**. "Grave" = **1** otalgia moderada/intensa, **2** dor há mais de 48 h, **3** febre ≥ 39 °C.

Idade	OMA com otorreia	Sintomas graves	Bilateral sem otorreia	Unilateral sem otorreia
6 meses – 2 anos	Antibiótico	Antibiótico	Antibiótico	Antibiótico ou observação
> 2 anos	Antibiótico	Antibiótico	Antibiótico ou observação	Antibiótico ou observação

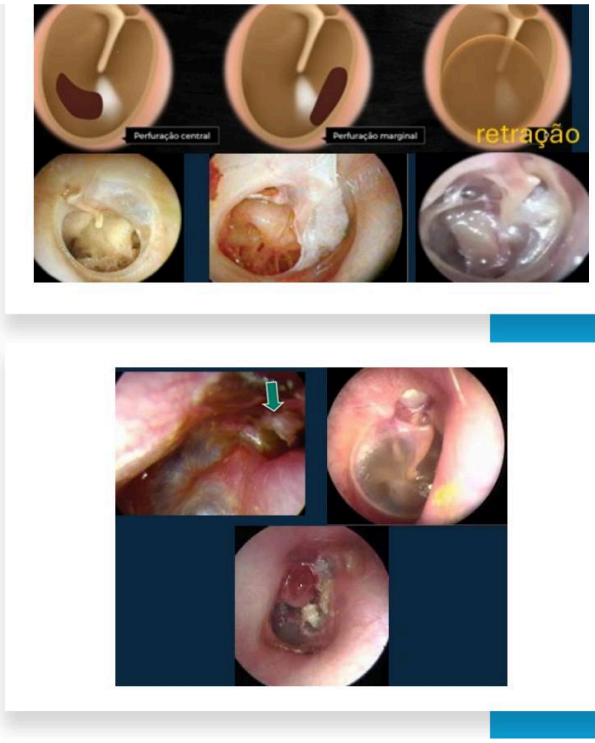
A tabela que a professora contornou em vermelho no slide. Observar = reavaliar obrigatoriamente em 48–72 h.

Como tratar a OMA: analgesia + **antibiótico VIA ORAL** (crianças 10 dias; adultos 5–7). 1ª opção: **amoxicilina** (adulto 500 mg 8/8 h; criança **80–90 mg/kg/dia**). Se usou amoxicilina nos últimos 30 dias ou tem **conjuntivite associada** (sugere H. influenzae, produtor de β-lactamase): **amoxicilina-clavulanato**. Alergia a penicilina: cefuroxima (2ª geração) ou ceftriaxona IM por 3 dias; ou clindamicina, macrolídeo (resistência). Refratária ou complicada: especialista → **tubo de ventilação**.

Otite média serosa (OMS, com efusão). A tuba funciona mal → **pressão negativa na orelha média → extravasamento de plasma** (líquido estéril, espesso). As causas são infecções respiratórias (pós-OMA) e obstruções mecânicas — a principal é a **ADENOIDE**, além de tumores. O quadro é de **hipoacusia (perda condutiva)** e atraso de fala, sem dor nem febre; a criança "não presta atenção". Otoscopia: MT retraída ou líquido atrás dela (nível, cor âmbar, bolhas). Conduta: **encaminhar ao especialista + corticoide nasal + pedir audiometria**; **tubo de ventilação se não drenar sozinho em 3 meses**.



OMS: líquido âmbar com bolhas atrás da MT; embaixo, o tubo de ventilação.



OMC: perfurações (central, marginal), retração e colesteatoma.

> ✎ *T10 · discursiva 1: caso de otite média serosa. (a) Diagnóstico: otite média serosa. (b) Causa:* ***adenoide*** *obstruindo a saída da tuba auditiva. (c) Tipo de perda auditiva:* ***condutiva****.*

Otite média crônica (OMC). Ligada a desnutrição, higiene inadequada, moradia precária e grande densidade demográfica — calendário vacinal NÃO é causa de otite crônica. Agentes: **Pseudomonas e S. aureus**. A **não colesteatomatosa (simples)** vem da disfunção tubária e resposta inflamatória a bactérias: perfuração ou retração, otorreia intermitente (pode estar seca), **normalmente indolor**. A **colesteatomatosa** pode ser congênita ou adquirida; **colesteatoma = acúmulo de queratina esfoliada**, com cheiro de "podre": perfurações/retrações grandes, lamelas brancas, **otorreia mucopurulenta** fétida, às vezes otalgia, e **erosão dos ossículos**. Conduta: encaminhar ao especialista, não molhar, **antibiótico**

tópico (ciprofloxacino; neomicina + polimixina), VO se persistir após limpeza e gotas; quase sempre precisa de **cirurgia (timpanomastoidectomia)**. A colesteatomatosa normalmente não para de vazar sozinha.

Lavagem de ouvido: quando sim, quando não

Material: cuba-rim, seringa de 20 ou 60 mL com bico, cateter de borboleta cortado em bisel, **água morna** (água fria dá vertigem). **Quando lavar:** cerume impactado — antes, emoliente (Cerumin 3 gotas 3×/dia por 5–7 dias), depois lavagem; corpo estranho inanimado **não biológico** (massinha, plástico, borracha); corpo estranho **animado**, depois de matar o bicho (álcool, lidocaína gel, óleo mineral). **Quando NÃO lavar:** **perfuração timpânica**; corpo estranho inanimado **biológico** (feijão, milho, arroz — incha com água), papel e algodão; infecção ativa.

Técnica: paciente sentado, examinador ao lado, paciente coberto e segurando a cuba junto ao rosto; tracionar a orelha levemente; jato com **pressão leve em direção ao teto** do conduto; secar.

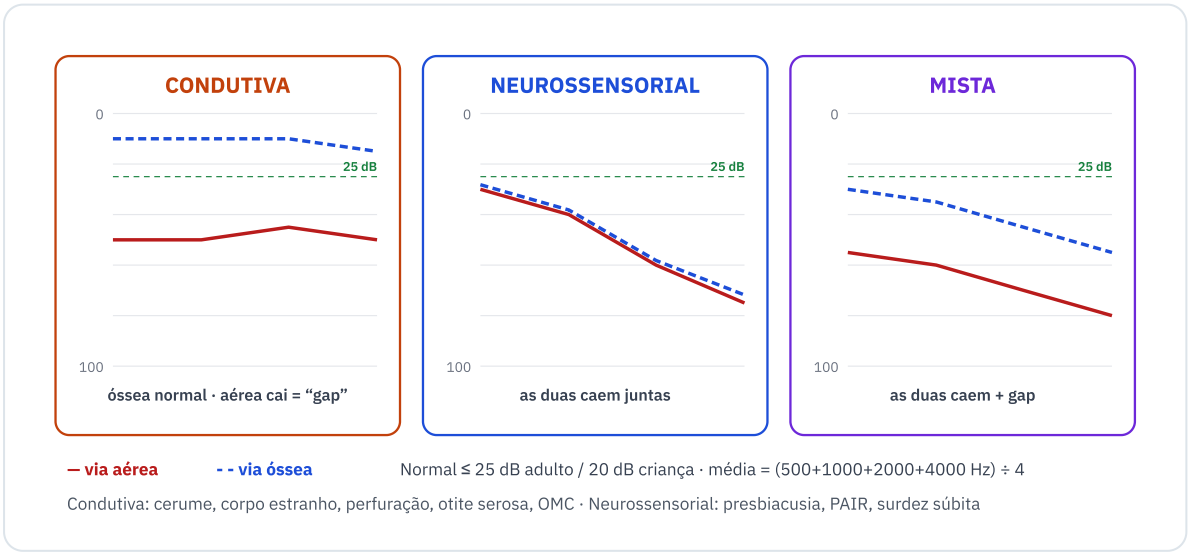
> **PEGADINHA T10**
> "Removido com lavagem e uso de emolientes" = **cerume**. "Não se faz lavagem" = **perfuração timpânica**. Bicho vivo: **matar primeiro** (óleo mineral) e só depois retirar.

Audiometria e imitanciometria

Quando pedir audiometria: paciente com queixa de hipoacusia, **depois de fazer a otoscopia** (cerume, otorreia ou tumor alteram o resultado e dão perda condutiva/mista). Com otoscopia normal, pensar em: **surdez súbita** (início há menos de 3 dias — urgência), **presbiacusia** (idoso), **PAIR** (perda induzida por ruído, trabalhadores), **otosclerose** (mulher jovem com história familiar), e criança com atraso de fala (OMS).

Tipos de exame: audiometria **tonal** (apitos em várias frequências), **vocal** (lista de palavras), condicionada/lúdica para crianças pequenas; **imitanciometria** (sonda no conduto que mede pressão e mobilidade da MT e função da tuba — não depende da colaboração, ótima em criança).

Interpretação: média quadritonal = (500 + 1000 + 2000 + 4000 Hz) ÷ 4. Limiar normal: **25 dB no adulto, 20 dB na criança**. Três tipos de perda: **condutiva** (algo bloqueia o som na orelha externa/média: cerume, perfuração, otite serosa), **neurossensorial** (cóclea ou nervo: presbiacusia, PAIR) e **mista**. Graus: leve, moderada, severa, profunda.



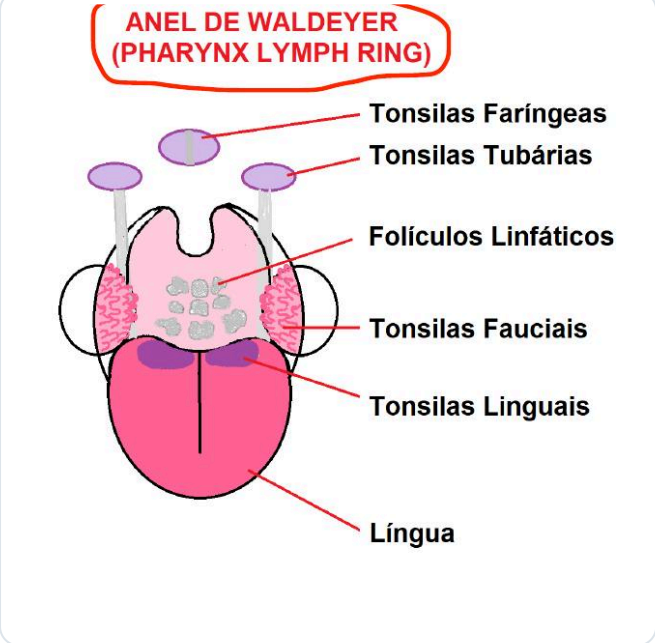
Como reconhecer o tipo de perda no audiograma.

Aparelho auditivo (AASI) grátis no SUS — classe 1: adultos com perda bilateral com média > 40 dB (moderada) e crianças até 15 anos com perda bilateral com média > 30 dB. Classe 2 (caso a caso): perda unilateral que prejudica integração social ou profissional.

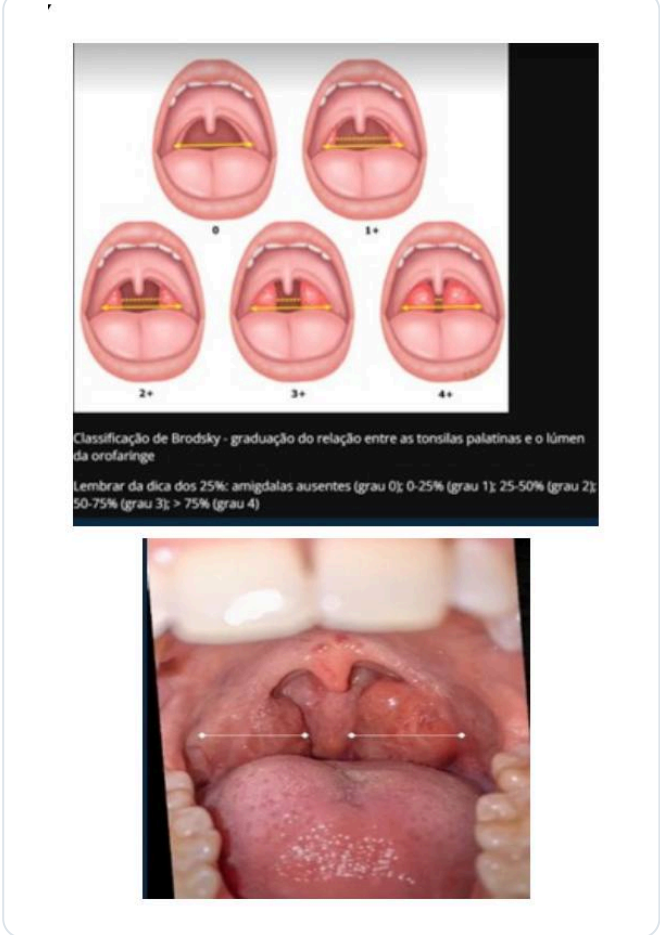
Aula 4 · Garganta

Amigdalites

O **anel linfático de Waldeyer** é formado pelas tonsilas faríngeas (adenoide), tubárias, palatinas (fauciais) e linguais, além de folículos linfáticos, e faz a proteção imunológica na entrada do trato aerodigestivo. As palatinas crescem mais dos **4 aos 10 anos**; as faríngeas (adenoide), dos **3 aos 7**; ambas involuem após a puberdade. Tirar amígdala/adenoide reduz anticorpos só a curto prazo, até gânglios, fígado e baço assumirem. A **hipertrofia tonsilar é a principal causa de apneia do sono** na criança, além de distúrbios respiratórios, de fala e deglutição e alterações craniofaciais. O tamanho é graduado pela **classificação de Brodsky** (grau 1 mal aparece; grau 4 as amígdalas se tocam/tocam a úvula).



Anel linfático de Waldeyer.



Classificação de Brodsky (graus 0 a 4).

Oroscopia: frente a frente, lanterna + abaixador (pode usar dois). Inspecionar lábios, dentes (cárie que drena pus contamina a região), língua ventral e dorsal, palato, amígdalas; palpar ductos salivares (o de **Stensen**, da parótida, abre perto do 2º molar superior), base da língua e assoalho da boca.

Lembrete que organiza tudo: as virais são as mais comuns. 75% dos casos em menores de 2 anos são virais; só 20% das faringotonsilites em crianças são estreptocócicas.

Virais

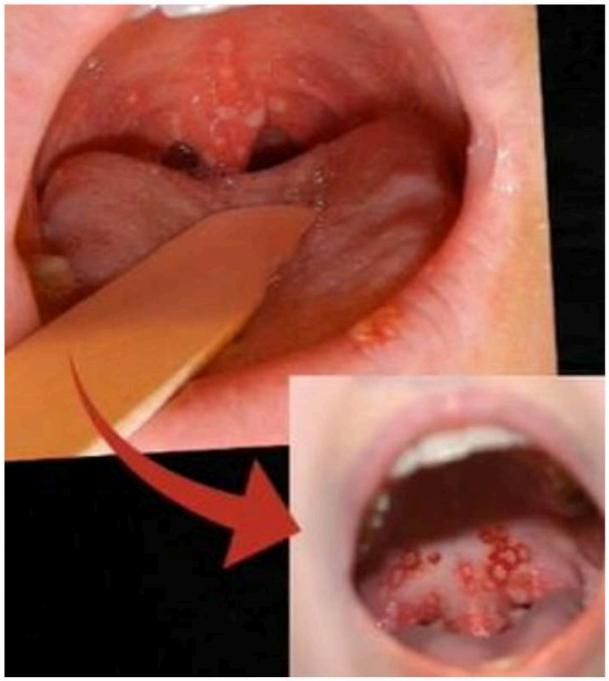
Amigdalite viral comum: adenovírus (20%), rinovírus, coronavírus, influenza, parainfluenza, VSR. Hiperemia/exsudato, febre, mialgia + **coriza e obstrução nasal** (a pista de vírus). Tratamento sintomático.

Mononucleose ("doença do beijo"): **Epstein-Barr (EBV)** (também CMV, toxoplasma, adenovírus, hepatites). O EBV infecta 90–95% da população; na infância costuma ser assintomático. Transmissão pela saliva, incubação de 4–6 semanas. O vírus vai para baço, fígado e linfócitos B. Pródromos (mal-estar, cefaleia, calafrios), depois **febre alta (39–40 °C) + adenomegalia cervical anterior e posterior**, exsudato eritematopultáceo com edema de úvula (1–2 semanas), **hepatoesplenomegalia**, mal-estar que pode durar 2 meses, e **exantema após amoxicilina/ampicilina**. Diagnóstico: hemograma com leucocitose, linfocitose e **> 10% de linfócitos atípicos**; anticorpos heterófilos (IgM). Tratamento de suporte (hidratação, repouso — risco de ruptura do baço —, analgesia, antitérmico); **corticoide não é justificado**.

Herpangina: **Coxsackie**, crianças < 5 anos, transmissão fecal-oral e gotículas, incubação 3–6 dias. Febre alta e **vesículas no palato mole e pilar posterior (mucosa NÃO queratinizada)**. Diferencial: herpes, que acomete mucosa queratinizada. Tratamento sintomático.



Mononucleose: exsudato extenso, branco-acinzentado.



Herpangina: vesículas no palato mole e pilares.

Bacterianas

Inespecíficas: M. pneumoniae, C. pneumoniae, estreptococos C e G; 3–10 dias de odinofagia, febre, adenopatia submandibular dolorosa, exsudato.

Estreptocócica: **S. pyogenes (β-hemolítico do grupo A)**, 20% das faringotonsilites infantis, **5–15 anos**, clima frio, gotículas, incubação de 4 dias; 20% da população é portadora assintomática. A preocupação é a **proteína M** (120 sorotipos) e as estreptolisinas O e S. Quadro: **exsudato amigdaliano + adenopatia cervical anterior dolorosa + febre**, sem coriza/tosse. Diagnóstico clínico; confirmação por **cultura (padrão-ouro)** ou teste rápido; o hemograma ajuda a separar da mononucleose; **ASLO indica infecção passada** (não serve para a aguda).

Centor modificado	Pontos
Febre	+1
Exsudato nas tonsilas	+1
Adenopatia cervical anterior	+1
Ausência de tosse	+1
Idade < 15 anos	+1
Idade > 44 anos	−1
−1 a 1: sem cultura nem antibiótico · 2–3: cultura ou teste rápido, antibiótico se positivo · 4–5: teste rápido ou cultura, antibiótico se positivo (risco de estreptococo > 50%)	

Escore do slide para decidir quando testar e tratar.

Tratamento: penicilina é a escolha. Penicilina G benzatina dose única IM — **600.000 UI se < 20 kg, 1.200.000 UI se > 20 kg**; penicilina V 25–40 mg/kg/dia em 2 tomadas por **10 dias**; **amoxicilina 40 mg/kg/dia em 3 tomadas** (na fala: 875 mg tem melhor adesão que 500). Alergia: macrolídeo. Produtores de β-lactamase: clavulanato, clindamicina, cefalosporinas. Na fala da professora: **não use azitromicina para amigdalite**.

Por que tratar: complicações não supurativas — **febre reumática** (valvulopatia), **glomerulonefrite**, PANDAS/coreia de Sydenham — e supurativas — abscesso periamigdaliano, otomastoidite, endocardite, pneumonia.



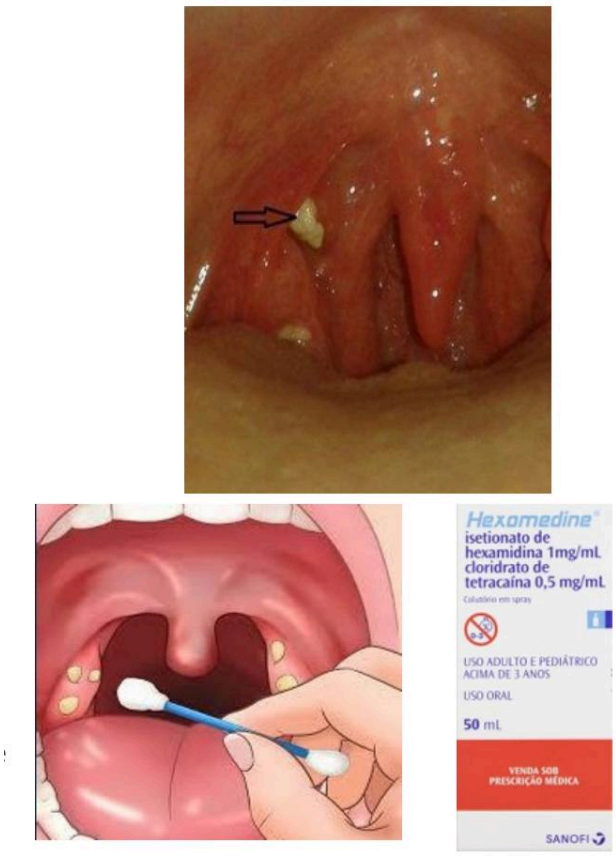
Amigdalite estreptocócica: exsudato em placas, hiperemia intensa.

Abscesso periamigdaliano (peritonsilar) — emergência

É a complicação supurativa da amigdalite: pus no espaço periamigdaliano, **mais no polo superior**, por **anaeróbios e gram-negativos** (> 50% produzem β-lactamase), em **adolescentes e adultos jovens**; recorre em 10–30%. Sintomas: **odinofagia intensa unilateral, trismo, febre e voz abafada ("batata quente")**; sinal clássico: **abaulamento unilateral com desvio da úvula**. Diagnóstico clínico; a **TC** confirma, separa de celulite e estadia. Tratamento de emergência: **drenagem + antibiótico** + anti-inflamatório. Antibióticos: penicilina + metronidazol; amoxicilina-clavulanato; clindamicina ± ceftriaxona. Se romper, pode descer para o mediastino.



Abscesso periamigdaliano: abaulamento do palato de um lado e úvula desviada.



Tonsilite caseosa: cáseo saindo da cripta.

> ✎ *T10 · discursiva 3: (a) **abscesso periamigdaliano** — escrever "amigdalite aguda" NÃO valeu. (b) Sinais: trismo, desvio da úvula, voz abafada, sialorreia, febre alta, dificuldade para deglutir, odinofagia. (c) Conduta: **drenar + antibiótico**.*

Recorrentes e crônicas

PFAPA (febre periódica, estomatite aftosa, faringite, adenite): febre a cada 3–6 semanas com aftas, faringite exsudativa e adenite cervical indolor; dura 3–6 dias, é imunomediada, começa antes dos 5 anos e some na adolescência, não afeta o crescimento. Tratamento: prednisona 1–2 mg/kg/dia (ou beclometasona); amigdalectomia ajuda.

Tonsilite crônica caseosa: acúmulo de material (cáseo/tonsilólito — um biofilme de bactérias e fungos) nas criptas, que inflama a cripta cronicamente. Causa **halitose** e sensação de corpo estranho; não é infecção aguda. Higiene oral e gargarejo/colutório (o efeito é mecânico); não espremer. Refratária ao colutório = **tonsilectomia**, a solução definitiva.

Tonsilectomia (fala em aula): amigdalite de repetição (4–6 episódios/ano), grau 4, apneia do sono. A pior complicação é a hemorragia pós-operatória persistente (anticoagulante e cocaína aumentam o risco).

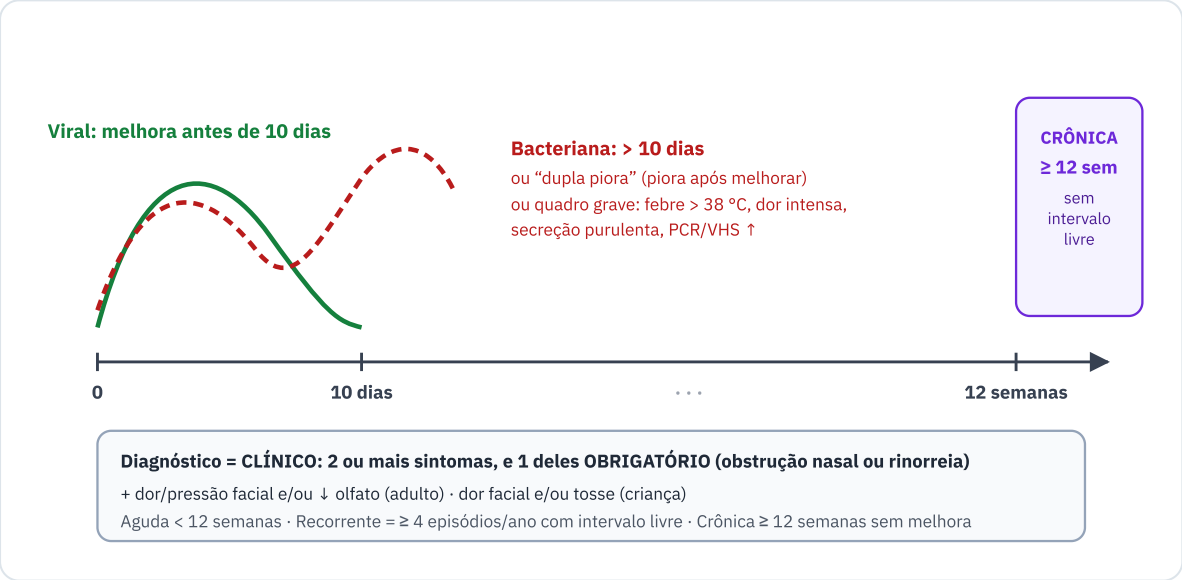
Outros diagnósticos na orofaringe: difteria (membrana que se estende ao palato), sífilis, gonocócica, herpética, paracoccidioidomicose, tuberculose, leishmaniose, leucemia.

Aula 4 · Nariz e seios

Rinossinusites

Rinossinusite é a inflamação do nariz e dos seios paranasais. O diagnóstico é **pelo quadro clínico**: **dois ou mais sintomas, sendo obrigatório um destes — obstrução/congestão nasal ou secreção nasal** (anterior ou posterior). Os sintomas adicionais são, no adulto, dor/pressão facial e **redução ou perda do olfato**; na criança, dor facial e **tosse**. Sinais objetivos (endoscopia: pólipos, secreção purulenta ou edema no meato médio; TC: alteração no complexo osteomeatal/seios) reforçam, mas não são obrigatórios.

A duração separa os tipos: **aguda < 12 semanas**, com intervalos livres; **recorrente aguda = 4 ou mais episódios por ano, com intervalo livre**; **crônica ≥ 12 semanas**, sem intervalo livre. Na crônica, os sintomas são os mesmos — inclusive a **perda de olfato**: "olfato e gustação preservados" NÃO é característica da rinossinusite crônica. A tosse ao deitar vem do gotejamento pós-nasal. A RSC é classificada pelo EPOS 2020 em primária e secundária.



Viral, bacteriana e crônica pelo tempo de doença.

Rinite × rinossinusite viral × bacteriana

	Rinite	Rinossinusite viral	Rinossinusite bacteriana
Causa	inflamação da mucosa (alérgica ou não)	rinovírus, influenza, parainfluenza	S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis
Sintomas	congestão, rinorreia, espirros, prurido	congestão, rinorreia clara, dor de garganta, tosse, febre baixa	secreção purulenta, dor/pressão facial intensa, febre > 38 °C, PCR/VHS ↑, dupla piora

	Rinite	Rinossinusite viral	Rinossinusite bacteriana
Duração	crônica ou episódica	< 10 dias	> 10 dias sem melhora ou piora após 5–7 dias

Tabela da aula. Só 0,5–2% das IVAS virais do adulto viram bacterianas.

Epidemiologia. Aguda: vírus (rinovírus, influenza, parainfluenza, adenovírus, coronavírus) e bactérias (S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis). Criança em idade escolar tem 7–10 resfriados/ano; adulto, 2–5 episódios virais/ano. Crônica: S. aureus, Pseudomonas (fibrose cística), Aspergillus (fúngica alérgica); afeta ~10% dos adultos.

Exames: quando pedir

Viral aguda: sem exames; **NÃO pedir RX de face**. **Bacteriana aguda:** microbiologia não é de rotina — só se não responder ao antibiótico empírico + corticoide nasal ou se houver sinais graves/complicação: sepse, **edema/eritema periorbitário, proptose**, diplopia, oftalmoplegia, queda da acuidade visual, cefaleia intensa, edema frontal, sinais meníngeos/neurológicos. Nesses casos, **TC de face**. **Crônica:** endoscopia nasal, **TC dos seios (exame de escolha)**, IgE/teste alérgico, eosinófilos, investigar imunodeficiência. **Fúngica:** histopatologia (eosinófilos, hifas, cristais de Charcot-Leyden), cultura fúngica, RM com contraste.



Edema palpebral: sinal de complicação orbitária da rinossinusite — pede TC e avaliação urgente.

> ✎ *T10: uma questão tinha como resposta "edema palpebral e ptose" — os sinais de complicação orbitária (o slide fala em edema/eritema periorbitário e proptose).*

Tratamento

Tipo	Quando dar antibiótico	Antibiótico	Duração
Pós-viral	> 10 dias, grave, piora após melhora	amoxicilina ou amoxi-clav	7–10 dias

Tipo	Quando dar antibiótico	Antibiótico	Duração
Bacteriana aguda	> 10 dias, grave, piora após melhora	amoxicilina 500 mg 8/8 h ou amoxi-clav	5–7 dias (10–14 se grave)
Crônica (exacerbação)	exacerbação, falha, cultura +	amoxi-clav 875/125 12/12 h, doxiciclina	2–4 semanas
Crônica (manutenção)	prevenir exacerbações	claritromicina 250 mg 1×/dia, eritromicina	3–6 meses (clari)
Crônica secundária	conforme a causa	azitromicina, ciprofloxacino...	conforme
Fúngica	infecção fúngica confirmada	itraconazol, voriconazol + desbridamento	3–12 meses

Tabela de tratamento da aula.

Junto ao antibiótico: **lavagem nasal com soro** (cabeça levemente para frente, para não ir para o ouvido) e **corticoide nasal**. Alternativas na alergia/falha (fala em aula): macrolídeos (claritromicina), cefalosporinas, quinolona respiratória, sulfametoxazol-trimetoprim. **Seguimento na crônica:** 2–4 semanas (SNOT-22, endoscopia, SF-36) → 3 meses (SNOT-22, endoscopia, eosinófilos e IgE) → 6–12 meses (TC, resposta a biológico). O **SNOT-22** é o questionário de 22 itens de qualidade de vida na RSC.

Aula 5 · Urgências

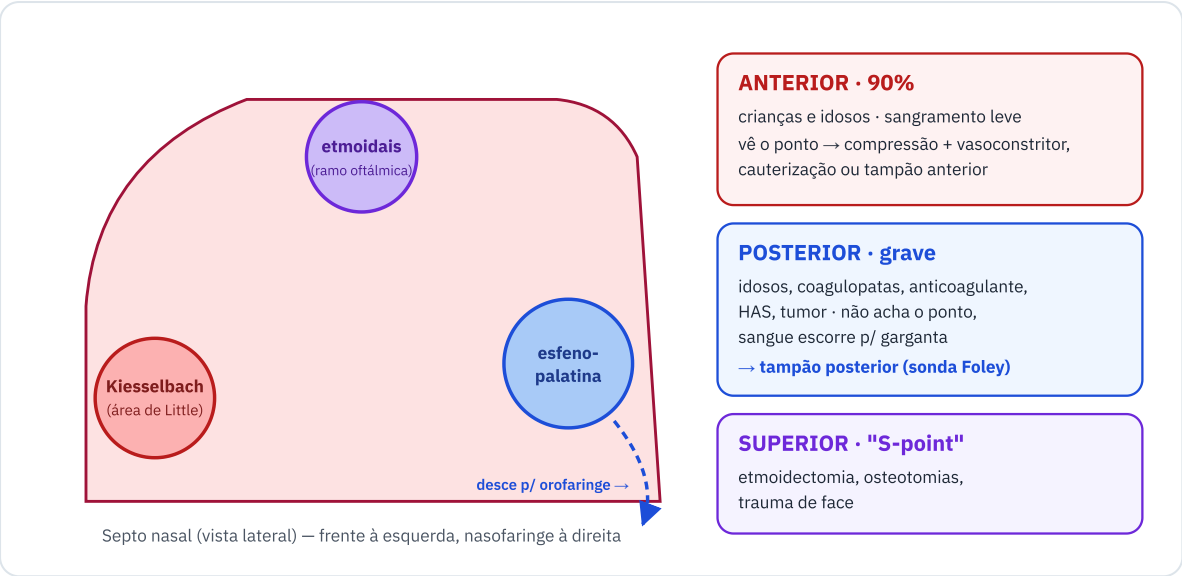
Urgências e emergências em ORL

Urgência exige atendimento rápido mas não é necessariamente fatal; **emergência** põe a vida em risco imediato.

Epistaxe

O sangramento nasal tem três territórios, e saber de onde vem decide a conduta (topodiagnóstico):

Anterior = plexo de Kiesselbach, na área de Little (septo anterior): crianças e idosos, sangramento leve, **90% dos casos**. **Posterior = artéria esfenopalatina** (nasal lateral posterior, nasosseptal): idosos, coagulopatas, uso de medicamentos, tumor — **sangramentos graves**. **Superior = artérias etmoidais**, ramos da oftálmica (S-point): etmoidectomia, osteotomias, trauma de face.

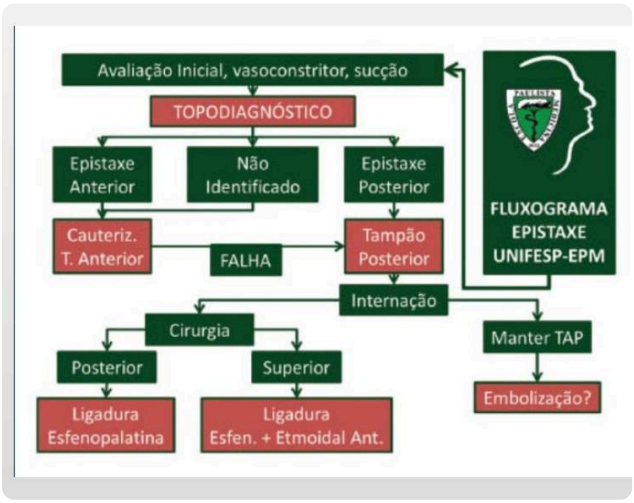


Os três territórios da epistaxe.

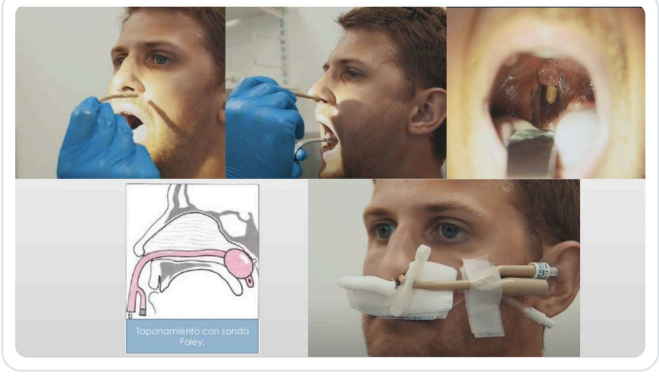
Causas (slide): doenças — rinossinusite, coagulopatias, **síndrome de Rendu-Osler-Weber**; drogas e medicamentos (cocaína, anticoagulante/AAS, vasoconstritor nasal crônico); traumas — **trauma digital** (dedo no nariz), **fraturas nasais**, cirurgias; tumores; tabagismo; perfuração septal; e **hipertensão sem controle**.

Os sintomas são sangue pelo nariz e, no posterior, sangue descendo pela garganta (o paciente engole, pode vomitar sangue). Salivação excessiva NÃO é sintoma de epistaxe.

Abordagem (fluxograma UNIFESP): estabilização (ATLS) → história (duração e volume da perda, comorbidades, medicamentos) → paciente **sentado**, inclinado para frente, cuspindo o sangue (deitado ele engole) → **compressão + vasoconstritor** (oximetazolina; com lidocaína para conforto) → topodiagnóstico → laboratório (hemograma, coagulograma) se volumoso → controle da PA se em crise. **Ácido tranexâmico** traz benefício no paciente internado. Anterior → **cauterização ou tampão anterior**. Posterior ou não identificado → **tampão posterior** (internação). Falha → cirurgia: **ligadura da esfenopalatina** (posterior) ou da etmoidal anterior (superior), ou embolização.



Fluxograma de epistaxe da aula (UNIFESP).


Tamponamento posterior com sonda Foley.

Tamponamento posterior: sonda **Foley** (nº 16) com lidocaína gel pelo nariz até aparecer na orofaringe; insufla o balão com 10–20 mL de **água destilada**, traciona até encaixar na coana e fixa sem tracionar demais (necrose da asa nasal); tampão anterior completa. É desconfortável: analgesia, ansiolítico, antiemético. O tampão não fica mais de 3 dias, e se dá **antibiótico** enquanto ele estiver (corpo estranho).

> ✎ *T10 · discursiva 2: epistaxe posterior. (a) Local: **posterior**. (b) Por quê: não se identifica o ponto na rinoscopia anterior e o sangue **drena para a orofaringe**. (c) Artéria: **esfenopalatina**. (d) Anterior × posterior: a anterior é a mais comum; a posterior é mais difícil de controlar e se associa a anticoagulante, anti-hipertensivo (HAS), imunodeprimido, idoso.*

Angina de Ludwig

Celulite/infecção grave do assoalho da boca e região submandibular, quase sempre de **origem dentária** (abscesso de raiz, extração mal feita), polimicrobiana (anaeróbios, gram + e –). Edema maciço do pescoço e do assoalho, que empurra a língua para cima e para trás: **risco de asfixia** e de mediastinite; trismo e fala arrastada. Letalidade alta. Conduta: internação, **via aérea** (traqueostomia se não intubar), antibiótico de amplo espectro + corticoide, drenagem cirúrgica.



Angina de Ludwig: edema submandibular e do assoalho da boca empurrando a língua.

Corpos estranhos

Comuns em crianças pequenas (~2 anos): miçanga, milho, pipoca, moeda, **pilha de relógio (urgência: corrosiva)**. **Corpo estranho nasal na criança = rinorreia unilateral com odor fétido** (a T10 trouxe o caso de uma criança com odor fétido na fossa nasal direita). Não tentar retirar com pinça sem experiência (empurra para dentro). Objeto radiopaco aparece no RX. Na garganta, espinha de peixe: não mandar comer pão, não puxar às cegas.

Miíase (larvas no ouvido, nariz ou garganta): primeiro **matar as larvas** — **afogar com óleo mineral** (ou de cozinha) —, depois retirar. Larva viva puxada morde e se aprofunda.

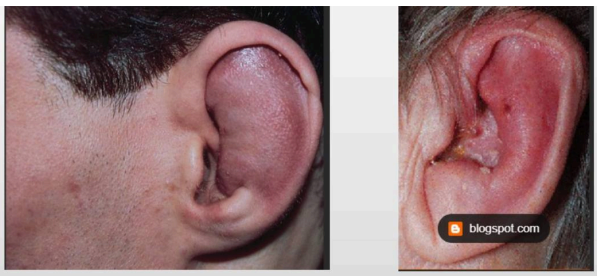
> **PEGADINHA T10**
> "Afogamento em óleo mineral" para corpo estranho animal. E lembre: corpo estranho no conduto externo dá dor, hipoacusia, plenitude — **não** dá distúrbio de equilíbrio.

Outras urgências

Fratura de laringe e traqueia: trauma cervical (soco, linha de cerol, cinto de segurança no pescoço); colapso → via aérea → traqueostomia. **Abscesso de nariz**: espremer espinha, picada, coçar; destrói a cartilagem e o nariz "desaba" → antibiótico e drenagem. **Condrite por trauma de orelha** (lutadores, piercing): hematoma/abscesso na cartilagem pouco irrigada → necrose e "orelha em couve-flor" → **drenagem imediata**.



Abscesso de nariz e celulite nasal.



Condrite/hematoma de orelha.